

KC桌面——外资精译

中国医药与生物科技

中国医药与生物科技：ASCO 2026

第三部分——总结（基本面再次重要之时）

ASCO 之后，医疗保健股遭遇了近期历史上最严重的打击。估值倍数处于或低于 2024 年 4 月的低谷。我们看不到任何基本面负面因素可以解释资金外流，在这一点上，这肯定超出了基本面的范畴。尽管如此，以下是在等待趋势转变期间对 ASCO 后观点的总结。

科伦博泰（O）：sac-TMT

成为肺癌中最可信的免疫肿瘤学合作伙伴（见本系列第一部分）。科伦的演示以更高的 ORR、更深的肿瘤缩小以及 sac-TMT+pembro 相比单独使用 pembro 更持久的应答强化了这一论点。因此，强大的 OS 获益在数据成熟时更有可能成立。在一线治疗之外，sac-TMT 在二线及以上 EGFR 突变非小细胞肺癌中具有差异化优势，它是该领域唯一具有统计学显著 OS HR 的药物。此外，合作伙伴默克（由 Courtney Breen 覆盖）最近宣布的晚期子宫内膜癌全球首个 III 期阳性结果，为中国以外地区增添了重要验证。科伦的管线不仅限于 sac-TMT：SKB500（B7H3 ADC）在二线及以上小细胞肺癌中显示出差异化的安全性特征。

科伦自周一以来下跌了 15%（年初至今持平）。我们认为该股在基本面上存在最大失衡（自 ASCO 以来有强劲的增量收益，无悬而未决的问题），并且是动能反转时的最佳机会。

信达生物（O）：IBI363

在免疫肿瘤经治患者这一竞争较少的细分市场中表现出色，并显示出显著的总生存期尾部效应：鳞癌 24 个月 OS 为 48%，腺癌为 43%，而多西他赛组分别为 8% 和 21.7%，Dato-DXd 在腺癌中为 29%。在一线患者中，IBI363 在所有试验中显示出最高的 ORR 86%。PD-1 × IL-2 β 双特异性设计最终可能不仅挑战当前的 PD-1 单药疗法，还会挑战第一波 PD-1 × VEGF 双特异性抗体。

信达自周一以来下跌了 8%（年初至今持平）。这是另一个失衡，ASCO 后 IBI363 前景改善，并且今年宣布了两项重大交易（与礼来和辉瑞，由 Courtney Breen 覆盖）。玛仕度肽销售风险也应可控（见我们的 GLP1 销售追踪器）。信达将在即将举行的 ADA 会议上报告其新 GLP-1 资产（包括口服 GLP-1 FIH 数据）的最新进展。我们认为信达是除科伦之外的另一个特质性机会。

康方生物（MP）：尽管 ASCO 讨论者给出了尖锐评论，但 AK112 强劲的 OS HR 是首次在该领域取得的成就，无论是 AK112、任何 PD-1 × VEGF，还是任何涉及 I/O 和 VEGF 机制的疗法。我们相信这对全球 HARMONi-3-sq 试验有积极的启示作用，该试验将于 2026 年第三季度公布最终 PFS 和中期 OS 数据。同时，H-2（OS 不显著，鳞癌和非鳞癌）和 H-6（OS 显著，仅鳞癌）的结果综合来看，并未让我们对 HARMONi-3-nsq 更有信心——要赢得更大的组织学亚型仍是一场艰苦的战斗。

我们还在此总结了恒瑞医药的 Nectin-4 ADC 和贝达药业的 CDK4i（首次人体试验，一线治疗）的积极结果（尽管尚处早期）。

O - 跑赢大盘，M - 与大市持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖 6990.HK, 9688.HK 估值为 EV/Sales（倍）；9926.HK, 1093.HK, 1177.HK 基准年为 2024 年；来源：彭博，Bernstein 估计与分析。

详情

板块表现

当前回调 vs. 近期高点（2025 年）和低点（2024 年）

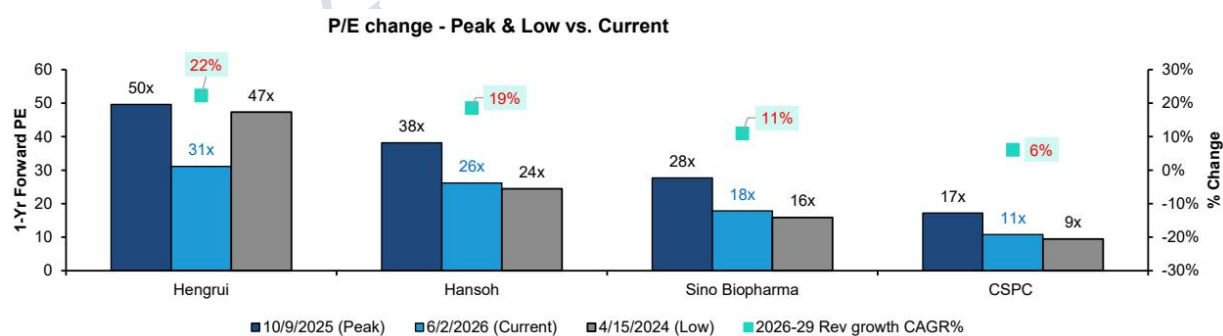
图表 1：自 2026 年以来板块表现持续波动并下跌



图表 1

来源：彭博，Bernstein分析

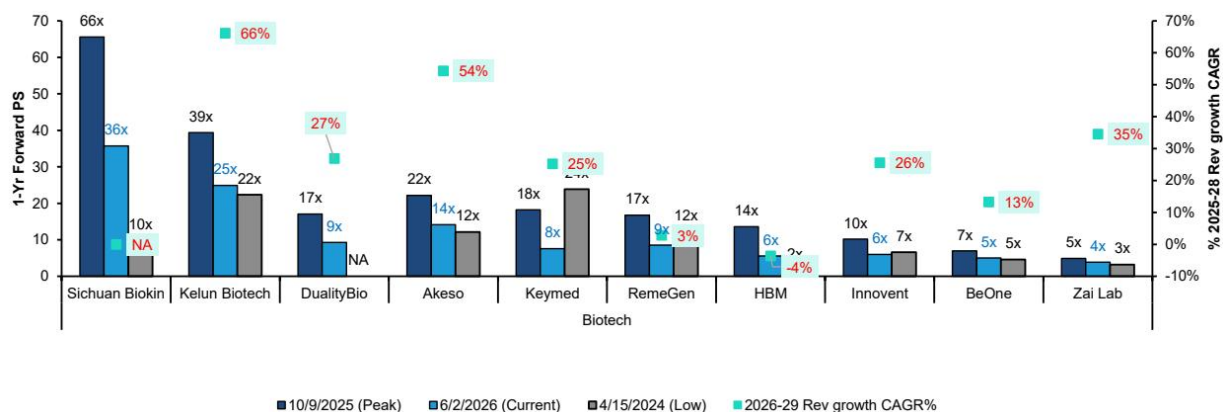
图表 2：以一年远期市盈率计，医药估值已接近历史低点



图表 2

来源：彭博，Bernstein分析

图表 3：以一年远期市销率计，中国生物科技公司自 2025 年板块高点以来出现下跌 市销率变化 - 高点与低点 vs. 当前



图表 3

注：Duality Bio、Keymed、RemeGen 和 HBM 未覆盖 来源：彭博，Bernstein 分析

ASCO 回顾

肺癌：三项资产角逐 300 亿美元 TAM

康方生物的 AK112 获得 OS 胜利但仍面临艰苦战斗；科伦博泰的 sac-TMT 面临最低的商业化障碍；信达生物的 IBI363 仍处早期，但在二线及以上治疗中以长生存期和一线治疗中最高应答率实现差异化

依沃西单抗联合化疗对比替雷利珠单抗联合化疗用于既往未经治疗的晚期鳞状非小细胞肺癌：III 期 HARMONi-6 试验的总生存期结果。——ASCO

SSGJ-707 (PF-08634404)，一种 PD-1/VEGF 双特异性抗体，作为单药治疗晚期非小细胞肺癌患者的 II 期试验更新结果。——ASCO

ROSETTA Lung-02 的 II 期数据，一项关于 pumitamig (PD-L1 × VEGF-A bsAb) 联合化疗用于一线非小细胞肺癌的全球随机 II/III 期试验。——ASCO

SHR-A2102 联合阿得贝利单抗作为一线治疗用于局部晚期或转移性鳞状或非鳞状非小细胞肺癌患者：一项 Ib/II 期研究结果。——ASCO

我们上周的报告强调了科伦博泰的 sac-TMT 在一线 PD-L1+ 非小细胞肺癌中的重要结果。在 PD-L1 全人群 (all-comer) 中，不同策略正显示出有意义的突破。

PD-1 x VEGF：在 HARMONi-6 试验中，AK112 将 mOS 提升至 27.0 个月，与对照组替雷利珠单抗 + 化疗相比，OS HR 为 0.66。在 PD-1 x VEGF 疗法中，ORR 持续高于 70%。这与早期的 HARMONi-2 试验形成鲜明对比，后者强烈的 PFS HR 并未在中期分析中转化为统计学显著的 OS。全体会议讨论者也给出了尖锐评论，质疑该试验基于其年龄和性别构成以及出血风险排除标准（见报告）。尽管如此，强劲的 OS HR 是 AK112、任何 PD-1xVEGF 或任何涉及 I/O 和 VEGF 机制的疗法在该领域首次取得的成就。我们相信这对全球 HARMONi-3-sq 试验有积极的启示作用，该试验将于 2026 年第三季度公布最终 PFS 和中期 OS 数据。同时，H-2（OS 不显著，鳞癌和非鳞癌）和 H-6（OS 显著，仅鳞癌）的结果综合来看，并未让我们对 HARMONi-3-nsq 更有信心——要赢得更大的组织学亚型仍是一场艰苦的战斗。

sac-TMT：我们在 ASCO 系列报告的第一部分中指出，OptiTROP-Lung05 结果预示着 sac-TMT 是现有 I/O (Keytruda) 的最佳增强剂，因其强烈的 PFS HR 为 0.35（意味着 PFS 超过 16 个月），OS HR 趋势为 0.55。科伦的演示进一步显示，与单独使用 pembro 相比，sac-TMT 联合 pembro 可带来更高的 ORR、深度缓解率和缓解持续时间。这些数据进一步支持最终 OS 阳性的论点。

PD-1 x IL-2：IBI363 在各组中实现了最高 ORR (85.7%)，但 PFS 和 OS 仍不成熟。由于 IBI363 在 I/O 经治患者中已显示出有利的生存期尾部效应（见下文），我们认为该双特异性抗体有更大潜力挑战现有 I/O 和 PD-1xVEGF。

Nectin-4：传统上，nectin-4 ADC 更多用于 mUC 类型的癌症。然而，在恒瑞公布的 NSCLC 数据中，报告了 80.8% 的 ORR——也处于上端，但在我们对这种非常规方法过于兴奋之前，需要更多关于 DoR 和生存期的数据。

图表 4：全球 NSCLC 市场机会分析：1L 和 2L+ 细分市场（TAM、发病率和治疗）

1L 新兴疗法：

- 迄今为止，AK112 已显示出 PFS 和 OS（仅鳞癌）获益——对患者群体的更广泛适用性有待证实；
- sac-TMT 对现有 Keytruda 标准疗法显示出最佳的附加效应；
- IBI363 在不受 PD-L1 或鳞癌/非鳞癌限制的情况下，获得了最高的缓解率。

2L+ 新兴疗法：

- Sac-TMT 在 EGFRm 患者中显示出令人信服的数据；AK112 未达到 OS 终点——IBI363 在非 AGA 患者中脱颖而出，成为领导者，这些患者除化疗外几乎没有其他选择。

注：a. 几乎所有 AGA 都发生在腺癌（非鳞癌）中；b. DTX = 多西他赛，PTX = 培美曲塞，GC = 吉西他滨
来源：ASCO、ESMO、NIH、PubMed、Nature、Bernstein 分析和估算

图表 5：国内领先 NSCLC 资产比较：临床数据和销售展望

注：a. 信达生物在肺癌领域拥有更高的 TAM，因为其在 I/O 经治患者中具有差异化优势；b. 来自 3-1.5mg/kg 剂量组队列的疗效；c. 来自 3mg/kg 剂量组队列的疗效

来源：公司披露、ASCO、WCLC、ClinicalTrials.gov、Bernstein 分析和估算

图表 6：在 1L PD-L1 全人群鳞状 NSCLC 中，AK112 + 化疗与替雷利珠单抗 + 化疗相比，显示出强烈且显著的 OS HR 为 0.66，以及数值上更长的中位 OS

注：a. 确认的 ORR；b. 3-1.5mg/kg 表示 IBI363 3 mg/kg 加 PDC 在第 1 周期，随后周期为 1.5 mg/kg Q3W 加 PDC；默克由 Courtney Breen 覆盖，BioNTech 由 Jeffrey Walch 覆盖，3S Bio 未覆盖

来源：ASCO、NEJM、ClinicalTrials.gov、Bernstein 分析

图表 7：在 1L PD-L1 全人群非鳞状 NSCLC 中，信达生物的 IBI363 + 化疗联合方案也显示出与同行相比最高的 ORR

注：a. 确认的 ORR；b. 3-1.5mg/kg 表示 IBI363 3 mg/kg 加 PDC 在第 1 周期，随后周期为 1.5 mg/kg Q3W 加 PDC

来源：ASCO、NEJM、ClinicalTrials.gov、Bernstein 分析

图表 8：重点观察试验的 ORR、PFS HR 和 OS HR

来源：Lancet、WCLC、ASCO、公司披露、Bernstein 分析

图表 9：在 2026 年 ASCO 上，HARMONi-6 公布了更新的安全性特征，irAE 和 VEGF 相关 TRAE 增加，但总体仍可耐受

注：a. TEAEs；b. 全因不良事件；* 3-1.5 mg/kg 为 65.2%；UD：在 2026 年 ASCO 论文中未披露

来源：Lancet、ASCO、NEJM、ClinicalTrials.gov、Bernstein 分析

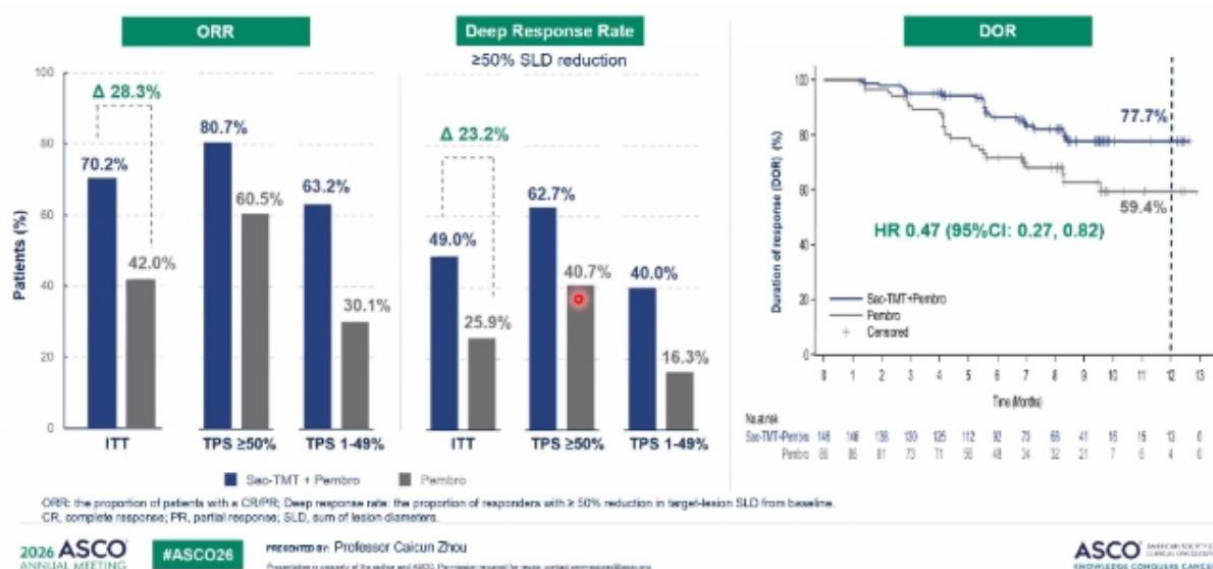
图表 10：在 1L PD-L1 阳性 NSCLC 中，sac-TMT + 帕博利珠单抗实现了 70.2% 的 ORR，PFS HR 为 0.35，OS HR 为 0.55，在各组中具有竞争力

来源：IASLC、WCLC、J Clin Oncol、ASCO、Bernstein 分析

图表 11：在 PD-L1+ NSCLC（1L）中，与帕博利珠单抗单药治疗相比，sac-TMT 联合帕博利珠单抗获得了更高的 ORR、深度缓解率和缓解持续时间

ORR、深度缓解和 DOR（BICR）

Sac-TMT + 帕博利珠单抗相比帕博利珠单抗改善了 ORR、深度缓解率和缓解持续时间



图表 4

ORR：达到 CR/PR 的患者比例；深度缓解率：靶病灶 SLD 较基线减少 $\geq 50\%$

的缓解者比例；CR，完全缓解；PR，部分缓解；SLD，病灶直径总和。报告人：周彩存教授 来源：科伦博泰

I/O 经治 NSCLC：ORR 趋同；IBI363 在生存期尾部显示出潜力

首创 PD-1/IL-2^α-bias 双特异性抗体 IBI363 (TAK-928) 用于晚期免疫治疗耐药非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者：一项 I 期研究的更新结果。 - ASCO

HLX43 (抗 PD-L1 ADC) 在晚期非小细胞肺癌患者中的疗效和安全性。 - ASCO

尽管作用机制多样化，ORR 趋同。无论药物类别如何，ORR 紧密聚集——B7-H3 ADC、TROP2 ADC、PD-L1 ADC 和双特异性抗体在成熟样本队列中均落在 22 – 37%

的区间内。异常值具有组织学特异性：复宏汉霖（未覆盖）的 HLX-43 在非鳞状 NSCLC 中领先，为 47.4% (n=19, 早期阶段)，而 IBI363 在鳞状细胞癌中领先，为

36.7% (n=30)，并且在该组织学中也报告了最长的 mPFS，为 10.1 个月。在非鳞癌中，IBI363 的 ORR 处于该范围的低端 (24%)。

IBI363 在 24 个月 OS 率方面具有差异化优势。IBI363 在鳞状细胞癌中实现了 47.8% 的 24 个月 OS 率，在腺癌中为 42.7%，而多西他赛分别为 8% 和 21.7%，Dato-DXd 在腺癌中为 29%。IBI363 在两种组织学中也记录了最长的 mOS（鳞状细胞癌 18.2 个月，腺癌 17.5 个月）。这种生存期尾部信号使得即将进行的 1b 期头对头试验（对比帕博利珠单抗+化疗）令人期待，在该试验中，与标准疗法的生存期直接比较可能为 IBI363 提供超越竞争对手的机会。

安全性——血液学负担最高的 ADC。B7-H3 ADC (HS-20093、YL201) 报告了最重的 ≥ 3 级 TRAE 负担，主要由中性粒细胞减少症 (≥ 3 级为 25.8 – 31.7%) 和贫血 (≥ 3 级为 17.2 – 25.0%) 驱动。HLX-43 居中， ≥ 3 级为 42.9%，而依沃西单抗 + 多西他赛较低，为 30.2%。IBI363 的 ≥ 3 级 TEAE 为 48.5%，由于报告惯例不同 (TEAE 与 TRAE)，不能直接比较，尽管血液学毒性同样占主导地位。没有单一类别拥有绝对的可耐受性优势。

图表 12：IBI363 在 mOS 和 48 个月 OS 率方面具有差异化优势

注：第一三共由 Miki Sogi 覆盖，BMS 由 Courtney Breen 覆盖，MediLink 和复宏汉霖未覆盖

来源：公司披露、ASCO、NEJM、Cell、Bernstein 分析

图表 13：B7H3 ADC 似乎比其他药物具有更高的毒性

来源：公司披露、ASCO、NEJM、Cell、Bernstein 分析

SCLC 中的 B7H3 ADC——来自科伦和石药的新星提供高 ORR 和差异化安全性

一项关于 SKB500 在局部晚期或转移性实体瘤患者中的开放标签、首次人体研究。- ASCO

一种新型 B7-H3 靶向抗体药物偶联物 SYS6043 在晚期泛肿瘤恶性肿瘤患者中的首次人体研究。- ASCO

小细胞肺癌 (SCLC) 未满足的需求。SCLC 占全球所有肺癌的 10 – 15%，每年新诊断病例为 350,000 – 400,000 例。尽管患病率低于 NSCLC，但疾病负担沉重：五年生存率约为 7%，而 NSCLC 为 26%。70% 的患者确诊时已处于广泛期 (ES-SCLC)，超出了手术选择的范围。目前 ES-SCLC 的 1L 标准疗法是铂类化疗 + PD-L1 抑制剂。对于 2L 及以后，治疗选择仍然有限：对于铂类耐药患者，有鲁比卡丁、拓扑替康和伊立替康；对于铂类敏感患者，有铂类再治疗。TCE tarlatamab 于 2024 年获批用于 2L+ ES-SCLC，报告 mOS 为 14.3 个月，相较于各种化疗的 10-11 个月范围有显著提升。

B7H3 ADC 类别迎来两位新竞争者。B7H3 在常见 SCLC 中过表达——60-80% 的 SCLC 肿瘤具有中到高水平的 B7H3 表面表达，使其成为理想靶点。B7H3 ADC 类别的领先者包括 HS-20093（翰森）和 DS-7300（第一三共，由 Miki Sogi 覆盖 / 默沙东，由 Courtney Breen 覆盖）。石药集团和科伦博泰本次均首次报告了各自 B7H3 ADC 的结果。值得注意的是，两种药物的 ORR 均较高，SYS6043 为 64-75%，SKB500 为 71%，为跨试验比较中的最高值，且相比标准疗法芦比替定改善 2 倍。生存数据尚未成熟。

在安全性方面，两种药物均优于基准试验。SKB500 的 ≥ 3 级 TRAE 率最低，为 16.5%，停药/死亡率为 0%——跨试验中数值上最佳的耐受性。然而，相对较小且处于早期的队列限制了直接可比性。

总体而言，我们认为科伦博泰和石药集团是 B7H3 类别中两位重要的新竞争者，尽管入局较晚，但在更优的安全性特征上尤其具有差异化优势。

图 14：在 2L+ SCLC 背景下，科伦博泰的 SKB500 和石药集团的 SYS6043 显示出令人鼓舞的 ORR

注：NR 表示未达到，NM 表示未成熟，NE 表示未评估；* 确认的 ORR；安进和默沙东由 Courtney Breen 覆盖，PharmaMar 未被覆盖 来源：公司披露，ASCO，Cell，NEJM，JCO，Bernstein 分析

图 15：在 2L+ ES-SCLC 背景下，科伦博泰的 SKB500 显示出最低的 TRAE 和 ILD 发生率

来源：ASCO，NEJM，ClinicalTrials.gov，Bernstein 分析

1L HR+/HER2 – 乳腺癌

摘要 1066：BGB-43395 首次披露选择性 CDK4 抑制剂 BGB-43395 联合来曲唑一线治疗转移性 HR+/HER2 – 乳腺癌 (BC) 的 1 期安全性扩展研究。— ASCO

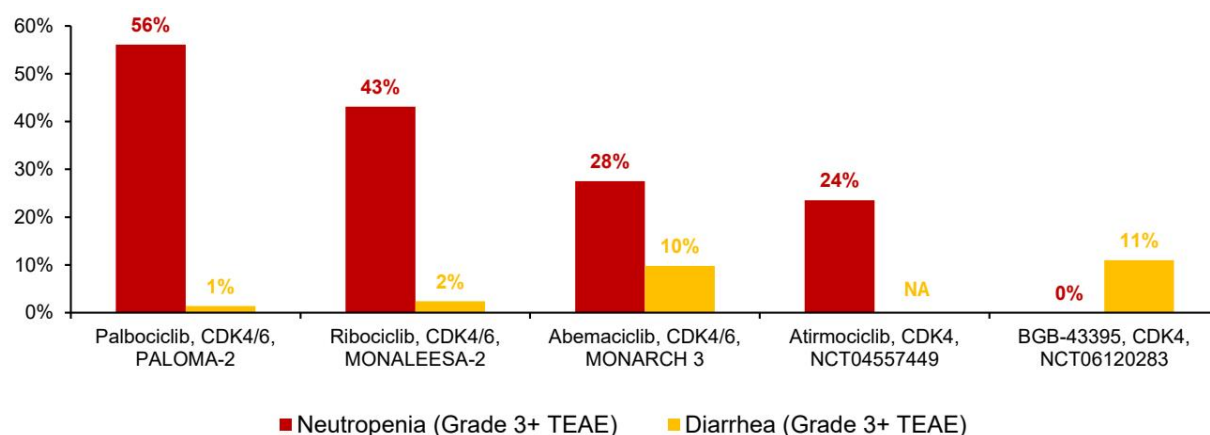
百济神州公布了其最快的实体瘤管线 BGB-43395 的阳性结果。在 1L HR+/HER2 – BC 中，BGB-43395 在 400mg BID 组实现了 68% 的 ORR，240mg BID 和 600mg BID 组分别为 58% 和 40%。该结果与其接近的竞争对手辉瑞的 CDK4i 药物 atirmociclib 相似，后者在 2025 年 ESMO 上报告的 ORR 为 69.7%。

与上一代 CDK4/6i 和 atirmociclib 相比，BGB-43395 还呈现出差异化的安全性特征。中性粒细胞减少症的 3 级及以上 TEAE 记录为 0%，表明血液学特征良好。腹泻的 3 级及以上 TEAE 似乎高于同类药物。然而，公司已表明，空腹时 G>3 的腹泻 TRAE 仅为 6%，随餐服用时为 0%，因此总体安全性特征可耐受。

图 16：在 HR+/HER2 – 乳腺癌中，百济神州报告 400mg BID 组的 ORR 为 68%，与 atirmociclib 相当

注：诺华由 Justin Smith 覆盖，礼来和辉瑞由 Courtney Breen 覆盖 来源：Journal of Clinical Oncology，Annals of Oncology，Pubmed，ASCO，公司披露，Bernstein 分析

图 17：在 1L HR+/HER2- BC 中，BGB-43395 报告可耐受的血液学毒性，中性粒细胞减少症的 G3 及以上 TEAE 为 0% 领先 CDKi 药物安全性特征比较（1L HER2- BC）



图表 5

对于 BGB-43395，空腹时 G>3 的腹泻 TRAE 为 6%，随餐服用时为 0%

来源：公司披露，ClinicalTrials.gov，Pharmcube，ASCO，Bernstein 分析

Nectin-4

迈威生物 9MW2821

Bulumtatug fuvedotin (BFv; 9MW2821) 联合特瑞普利单抗用于肌层浸润性膀胱癌（MIBC）围手术期患者：一项 2 期研究队列 A 的结果。— ASCO

Bulumtatug

fuvedotin (BFv; 9MW2821) 联合特瑞普利单抗用于局部晚期或转移性尿路上皮癌（la/mUC）患者：一项 1b/2 期研究的随访结果。— ASCO

石药集团 SYS6002

SYS6002 在晚期实体瘤中的一项 1b 期研究。— ASCO

恒瑞医药 SHR-A2102

SHR-A2102，一种靶向 Nectin-4 的抗体药物偶联物，联合 HRS-4642 用于既往治疗过的携带 KRAS G12D 突变的胰腺导管腺癌。— ASCO

围手术期 SHR-A2102，一种新型靶向 Nectin-4

的抗体药物偶联物，联合阿得贝利单抗用于肌层浸润性膀胱癌患者：一项 2/3 期研究的结果。— ASCO

SHR-A2102

联合阿得贝利单抗作为局部晚期或转移性鳞状或非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗：一项 1b/2 期研究的结果。— ASCO

MIBC 中的 NECTIN4 ADC：早期 pCR 相当，但队列规模较小。在肌层浸润性膀胱癌（MIBC）这一复发风险高的高危背景下，围手术期全身治疗被认为对改善长期结局至关重要。历史上，PD-(L)1 + 化疗一直是标准疗法，疗效中等（pCR 约 34%）。最近，PD-(L)1 + NECTIN4 ADC（enfortumab vedotin + keytruda）已成为一种新的标准疗法，具有改善的应答。在 ASCO 2026 上，迈威生物和恒瑞医药均报告了其 NECTIN4 ADC 联合疗法的早期围手术期数据，显示 pCR 率约为 48-67%，与 EV + Keytruda 方案大致相当（图 18）；然而，这些结果来自相对较小且不成熟的数据集（分别为 n=6 和 n=27），需要在更大规模的随机试验中得到确认。

mUC 中的 NECTIN4 ADC：Padcev 的成功似乎越来越可复制。在 1L 及后线转移性尿路上皮癌中，ASCO 2026 上展示的迈威生物和恒瑞医药资产的数据显示与 Padcev 相当的疗效。在 1L 背景下，迈威生物的 Bulumtatug

fuvedotin + 特瑞普利单抗联合疗法实现了 83.0% 的 ORR 和 12.9 个月的 mPFS，而 Padcev + keytruda 为 67.7%（确认）和 12.5 个月。在后线背景下，石药集团的 SYS6002 报告 ORR 为 41.0%，与 Padcev 单药报告的 40.6% ORR 大致一致（图 19）。

图 18：在围手术期 MIBC 背景下，尽管迈威生物和恒瑞医药资产的早期数据显示出与标准疗法（EV + Pembro）相当的结果，但仍需更大的样本量和更成熟的数据来确定疗效差异

注：阿斯利康由 Justin Smith 覆盖，迈威生物未被覆盖 来源：ASCO，NEJM，ClinicalTrials.gov，Bernstein 分析

图 19：在 1L 和 2L+ mUC 中，迈威生物似乎实现了与 Padcev 相比更高的 ORR 和 mPFS，石药集团的 SYS6002 显示出相当的结果且安全性更优 ASCO 2026

注：安斯泰来由 Miki Sogi 覆盖 来源：ASCO，NEJM，Bernstein 分析

公众号：KC桌面